Az ESV-modell terepi alkalmazása: rendszerszintű hatásvizsgálat és a biztonságos bázis megvonásának következményei

Záró módszertani jelentés

Szerző: Ódor Antal, független kutató

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor-antal@research.hu

DOI: 10.5281/zenodo.19758352

Budapest, 2026

Jogi nyilatkozat és hatókör

A jelen dokumentum reflektív szakmai módszertani jelentés, amely az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazásának tapasztalatait rögzíti. A dokumentum:

- **nem minősül szakvéleménynek, pszichodiagnosztikai vizsgálatnak vagy orvosi dokumentumnak;**
- **nem alkalmas és nem szánható bírósági, hatósági vagy fegyelmi eljárásban önállóan bizonyítékként való felhasználásra;**
- **nem tartalmaz valódi neveket, intézményi azonosítókat, pontos dátumokat vagy bármely természetes személyre nézve beazonosítható adatot;**
- **nem irányul semmilyen természetes vagy jogi személy ellen; esetleges rendszerkritikai megállapításai kizárólag a szakirodalomban dokumentált, általános pedagógiai és intézményi jelenségekre vonatkoznak, és semmilyen konkrét szervezettel, intézménnyel vagy személlyel nem hozhatók összefüggésbe.**

A dokumentumban megjelenő pedagógiai és pszichológiai fogalmak (pl. regresszió, behódoló válasz, gyászfázisok) kizárólag a hivatkozott tudományos irodalom alapján értelmezendők, és nem helyettesítik a szakképzett pszichológus, pszichiáter vagy gyermekvédelmi szakember diagnózisát vagy véleményét.

Adatvédelmi és etikai nyilatkozat

Anonimizálás

Az érintett gyermekek teljes mértékben anonimizálva szerepelnek (A-típus, B-típus, C-típus megjelöléssel). A szöveg nem tartalmaz valódi nevet, születési adatot, lakcímet, iskolai azonosítót, egészségügyi azonosítót vagy bármely más, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR) 4. cikk 1. pontja szerinti személyes adatot. Az esetleírások szintje megfelel a GDPR 89. cikke szerinti kutatási célú adatkezelésre vonatkozó anonimizálási követelményeknek.

Különleges adatok

A gyermekek fejlődési és egészségügyi háttere a GDPR 9. cikk értelmében különleges kategóriájú adatnak minősül. A jelen dokumentumban ilyen adat kizárólag általánosított, nem visszavezethető formában szerepel. Konkrét diagnózis, BNO-kód vagy egyéb egészségügyi azonosító nem kerül megnevezésre.

A dokumentum jellege és az etikai keretről szóló nyilatkozat

A jelen dokumentum reflektív szakmai napló és módszertani összefoglaló, amelyet a szerző gyógypedagógiai asszisztensként végzett terepi munkájáról, független kutatói minőségben készített. A dokumentum szerzője nem rendelkezik akkreditált kutatói vagy klinikai pszichológiai képesítéssel; a leírtak kizárólag szisztematikus laikus megfigyelésen, reflektív szakmai tapasztalaton és a hivatkozott tudományos irodalom önálló alkalmazásán alapulnak. A dokumentum nem minősül emberi alanyokon végzett tudományos kutatásnak a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, az 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) vagy a vonatkozó etikai irányelvek értelmében; ennek megfelelően formális etikai bizottsági engedélyeztetési kötelezettség nem terhelte.

A szerző rögzíti, hogy írásos tájékozott beleegyezési nyilatkozat az érintett gyermekek törvényes képviselőitől nem áll rendelkezésre. A dokumentum közzétételének jogalapja a teljes és visszafordíthatatlan anonimizálás: az esetleírások olyan általánosítási szinten kerülnek bemutatásra, amely mellett az érintett személyek a GDPR 4. cikk 1. pontja értelmében nem azonosíthatók, és az adat személyes adatnak nem minősíthető. Ennek megfelelően a közzétételhez tájékozott beleegyezés nem szükséges feltétel (GDPR 89. cikk; Infotv. 2011. évi CXII. törvény 4. §).

A szerző elismeri, hogy bármely jövőbeli, formalizált kutatási keretben - ahol az adatgyűjtés célja előre meghatározott és az anonimitás nem garantálható teljes körűen - az írásos tájékozott beleegyezés és az etikai bizottsági engedély megszerzése kötelező és vállalt feltétel.

Gyermekvédelmi megfelelés

A dokumentum tartalma megfelel az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) gyermekek érdekei védelmére vonatkozó rendelkezéseinek. A

szöveg semmilyen formában nem sérti és nem veszélyezteti az érintett gyermekek személyiségi jogait, méltóságát vagy jólétét.

Absztrakt

A jelen záró módszertani jelentés az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell egyéves terepi alkalmazásának kvalitatív esettanulmányait összegzi egy gyógypedagógiai ellátórendszer keretein belüli csoportban. A vizsgálat célja annak dokumentálása volt, hogy az érzelmi biztonság elsődleges intervenciós eszközként való alkalmazása milyen hatással van a különböző fejlődési háttérrel rendelkező, különleges bánásmódot igénylő gyermekek önszabályozási képességére, szociális kapcsolódására és regressziós mintázataira. Három szigorúan anonimizált eset elemzésén keresztül a jelentés azonosítja a modell hatásmechanizmusát, a segítő-gyermek kötődési kapcsolat nem tervezett megszakadásakor megjelenő retraumatizációs folyamatot, valamint rendszerszintű tanulságokat fogalmaz meg az intézményi érzelmi biztonság feltételeiről. A dokumentum módszertana megfigyeléses, kvalitatív esetleírás; az eredmények hipotézisalkotó jelleggel bírnak, és nem általánosíthatók reprezentatív mintán alapuló vizsgálat szintjén.

Bevezetés és elméleti alapozás

A jelen jelentés az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell egyéves terepi alkalmazásának tapasztalatait összegzi. A modell Bowlby (1969) kötődéselméletébe gyökerezik, és abból a premisszából indul ki, hogy a gyermek viselkedése nem szándékos provokáció, hanem az idegrendszer adaptív válasza a megélt biztonságra vagy stresszre. Ebből következően a tüneti kezelés (büntetés-alapú megerősítés, következménypedagógia) helyett az oki szintű beavatkozás - az érzelmi biztonság mint elsődleges fejlesztő közeg - dominált az intervenciókban.

Az ESV-modell három egymásra épülő szinten értelmezi a gyermeki megnyilvánulásokat. Az Érzelem szint az aktuális idegrendszeri aktiváltsági állapotot írja le. A Stressz szint a kumulatív terhelést és a regulációs kapacitás korlátait jelöli. A Viselkedés szint a látható, sokszor tüneti reakciókat tartalmazza. A modell hozzáadott értéke, hogy a viselkedés mögé lát, és az eredeti stresszforrást azonosítja beavatkozási célpontként - összhangban van der Kolk (2014) neurobiológiai alapú trauma-modelljével és Perry és Szalavitz (2006) fejlődési trauma-elméletével.

A terepi dokumentáció célja kettős volt: egyrészt a módszertan hatásának rögzítése eltérő fejlődési háttérrel rendelkező gyermekek esetén; másrészt egy nem tervezett körülmény - a kötődési személy intézményi döntés folytán bekövetkező eltávolítása - hatásainak szakmai elemzése.

Módszertan

A vizsgálat kerete és típusa

A dokumentáció természetszerű körülmények között végzett, résztvevő megfigyelésen alapuló kvalitatív esetleírás. A vizsgálati időszak a 2025/2026-os tanév; helyszíne egy gyógypedagógiai intézmény csoportja. A megfigyelési egység az egyéni gyermeki fejlődési ív, amelyet a szerző rendszeres megfigyelési naplóban rögzített. A vizsgálat nem kísérlet; nem alkalmazott véletlenszerű mintavételt, kontrollcsoportot vagy standardizált mérőeszközöket.

Az esetkiválasztás szempontjai

A három dokumentált eset célzott esetválasztáson alapul: olyan gyermekeket reprezentálnak, akik eltérő fejlődési háttérrel és eltérő válaszreakciókkal rendelkeznek, így a modell alkalmazhatóságának különböző aspektusait teszik láthatóvá. Az esetek nem tekinthetők reprezentatív mintának.

Adatgyűjtés és -feldolgozás

Az adatgyűjtés eszközei: (1) folyamatos, szisztematikus megfigyelési napló; (2) a csoporttal párhuzamosan dolgozó pszichológussal folytatott konzultációk összegzése; (3) szülőkkel folytatott informális tájékoztató kommunikáció; (4) a szerző reflektív szakmai önértékelése. Standardizált diagnosztikus mérőeszközök nem kerültek alkalmazásra; a dokumentáció nem helyettesíti a szakpszichológiai vagy pszichiátriai vizsgálatot.

Módszertani korlátok

A szerző egyszerre töltötte be a terepi munkát végző gyógypedagógiai asszisztens és a megfigyelő független kutató szerepét, ami megerősítési torzítás és megfigyelői elfogultság kockázatát hordozza. Ezt az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni. Az esetszám (N=3) nem teszi lehetővé általános érvényű következtetések levonását.

Esettanulmányok

Összefoglaló táblázat

Eset típusa	Kezdeti állapot	Az intervenció hatása	Krízis-reakció
A-típus Korai kötődési	***Reaktív agresszió; kizárólagos***	***Önálló munkavégzés; spontán proszociális***	***Affektív sokk, kontrolling stratégiák, majd***

trauma	***önvédelmi fókusz.***	***viselkedés megjelenése.***	***viselkedéses regresszió a kötődési személy eltávolításakor.***
B-típus Veszteségfeldolgozás	***Gyászfolyamatba rekedt; tagadás és izoláció.***	***Érzelmi nyitás; harag-fázis felszínre kerülése; fokozódó kortárs-kapcsolódás.***	***Átmeneti bizonytalanság; fokozott vigaszkereső viselkedés.***
C-típus Sérülékeny fejlődési minta	***Mélyen rögzült maladaptív sémák; korlátozott érzelmi elérhetőség.***	***Stagnálás (az intervenciós idő és erőforrások elégtelensége).***	***A maladaptív sémák változatlan fennmaradása.***

A-típusú eset: Korai kötődési trauma

Az érintett gyermek fejlődési anamnézisét korai életkori megpróbáltatások terhelik, amelyek a biztonságos kötődés kialakulását akadályozták. A kezdeti időszakban reaktív agresszió és kizárólagosan önvédelmi fókuszú magatartás volt megfigyelhető - e viselkedésformák a korai kötődési depreváció jól dokumentált adaptív következményei (Zeanah & Gleason, 2015).

Az ESV-modell alkalmazása nyomán - a következetes érzelmi biztonság megteremtésével - fokozatosan megjelent az önálló feladatvégzés képessége, majd spontán proszociális magatartás is. Ez a kizárólagos önvédelmi fókuszból való elmozdulást jelzi.

Szakmai szempontból figyelmet érdemel az úgynevezett behódoló (fawn) válaszreakció azonosítása (Walker, 2013): a gyermek fokozott megfelelési viselkedést mutatott azokhoz a felnőttekhez, akik következetesebb, negatív megerősítésen alapuló módszereket alkalmaztak. A trauma-informált szakirodalomban ezt a jelenséget jól leírták: a gyermek idegrendszere a kontrollálatlan fenyegetéssel szemben a megfelelési stratégiát aktiválja (Walker, 2013; van der Kolk, 2014). E viselkedés félreértelmezése komoly fejlesztési kockázatot hordoz, mivel valójában stressz-reaktivitást és nem belső önszabályozást tükröz.

B-típusú eset: Veszteségfeldolgozási folyamat

Az érintett gyermek egy akut veszteséggel összefüggő krízis nyomán érkezett a csoportba. A kezdeti időszakban tagadásos és izolációs stratégiák domináltak, amelyek Kübler-Ross (1969) modelljében a gyász első fázisának felelnek meg.

Az ESV-alapú intervenciók és a párhuzamos pszichológusi konzultációk szinergikus hatást fejtettek ki: a mindennapi érzelmi biztonság lehetővé tette a gyermek számára, hogy a célzott terápiás munkában is mélyebb rétegekhez jusson. A tanév során a harag

fázisának megjelenése, majd a fokozódó kortársakhoz való kapcsolódás volt megfigyelhető - a veszteségfeldolgozás természetes folyamatának megindulásával összhangban.

C-típusú eset: Sérülékeny fejlődési minta

A harmadik eset a modell alkalmazhatóságának korlátaira mutat rá. Az érintett gyermek jelentős mértékű és mélyen rögzült maladaptív mintázatokat mutatott. Az ESV-modell alkalmazása - az intézményi keretek (idő, frekvencia, erőforrások) elégtelensége következtében - nem tudott tartós változást elindítani; a sémák stagnálása volt megfigyelhető.

Ez az eset fontos tanulságot hordoz: az érzelmi biztonság megteremtése szükséges, de nem elégséges feltétele a változásnak. A mélyen rögzült, korai kötődési sérülésekből eredő maladaptív minták kezelése hosszú távú, multidiszciplináris beavatkozást igényel (Perry & Szalavitz, 2006). Az eset módszertanilag nem tekinthető kontrollcsoportnak - az intervenciós körülmények hiányosságait dokumentálja, nem a beavatkozás nélküli állapotot kísérleti keretek között.

A biztonságos bázis megvonásának hatásmechanizmusa

A nem tervezett körülmény

A terepi munka kényszerű lezárása - a kötődési személy intézményi döntés következtében való eltávolítása - egy nem tervezett körülményt teremtett, amelynek megfigyelése adatokat szolgáltatott a kötődési biztonság szerepéről. Hangsúlyozandó, hogy ez nem tervezett kísérlet, hanem egy intézményi döntés nem szándékolt fejlődési következménye.

A regressziós folyamat fázisai

A változás hírére az A-típusú eset gyermeknél fázisosan zajló regressziós folyamat indult el: (1) affektív sokk-reakció; (2) kontrolling kötődési stratégiák aktiválódása; (3) viselkedéses regresszió, a korábban megszerzett fejlődési vívmányok látszólagos elvesztésével. E folyamat Bowlby (1969, 1980) szeparációs és veszteségelméletével, valamint Ainsworth és munkatársai (1978) kötődési rendszer-elméletével összhangban értelmezhető.

Hangsúlyozandó: a regresszió nem viselkedészavar és nem fegyelmezési hiány következménye. Neurobiológiai szempontból az idegrendszer a biztonságos bázis elvesztésére túlélési stratégiákkal reagál, visszatérve arra az alkalmazkodási szintre, ahol

a külső szabályozó személy még jelen volt (Schore, 2003). A tünetek súlyosbodása kommunikatív funkciót tölt be: a biztonság visszaszerzésére irányuló jelzés.

Rendszerszintű tanulság

Az intézményi döntéshozatalban a kötődési kapcsolatok stabilitása fejlődési és jóléti szempontként kell, hogy megjelenjen. A kötődési személyek cseréjének gyermekközpontú előkészítése - fokozatos átmenet, az érzelmek nevesítése, az új gondozó személlyel való ismerkedési idő biztosítása - a retraumatizáció megelőzésének eszköze (van der Kolk, 2014).

Rendszerszintű tanulságok

Az érzelmi biztonság mint fejlesztő közeg

A terepi megfigyelések megerősítik a trauma-informált irodalom azon álláspontját, miszerint a gyermek fejleszthetősége - tanulási kapacitása, szociális kapcsolódása, önszabályozása - elválaszthatatlan az érzelmi biztonság minőségétől (van der Kolk, 2014). A kizárólag tüneti kezelésre orientált beavatkozás a stressz-reaktivitást növeli, és az idegrendszert olyan üzemmódban tartja, amely kizárja a fejlődési folyamatokhoz szükséges nyitottságot (Perry & Szalavitz, 2006). Ez a megállapítás a szakirodalomban konszenzusos álláspontnak tekinthető, és nem irányul semmilyen konkrét intézmény, személy vagy eljárás ellen.

A szülői közösség szerepe

A vizsgálati időszakban megfigyelhető volt, hogy a szülők fokozatosan aktívabb szerepet vállaltak gyermekeik érzelmi biztonsághoz való jogának érvényesítésében. A szülők partnerré válása a gyermek fejlődési folyamatában pozitív fejlemény, amely összhangban van a gyermek mindenek felett álló érdekének elvével (ENSZ Gyermekjogi Egyezmény, 1989, 3. cikk).

A külső referenciaszemély szerepe

A terepi tapasztalat alapján ajánlható, hogy különleges bánásmódot igénylő gyermekek esetén az intézményi rendszertől független, de azzal együttműködő referencia- vagy mentorszemély bevonása csökkentené a kizárólag belső rendszertől való függőséget, és a segítő-gyermek kapcsolat megszakadásakor puffert nyújtana.

A vizsgálat korlátai

- Az elemzés három esetre terjed ki; az eredmények nem általánosíthatók reprezentatív mintán alapuló vizsgálat szintjén.
- Nem áll rendelkezésre kontrollcsoport; a megfigyelt változások kizárólagosan az ESV-intervenciónak tulajdonítása módszertanilag nem megalapozott.
- A megfigyelő és az intervenció végzője azonos személy, ami megerősítési torzítás kockázatát hordozza.
- Az adatgyűjtés nem standardizált eszközökkel történt; a mérési validitás korlátozott.
- Formális etikai bizottsági jóváhagyás és írásos tájékozott beleegyezés nem áll rendelkezésre; ezek megszerzése jövőbeli formalizált kutatásban szükséges.

Konklúzió

Az ESV-modell terepi alkalmazása alátámasztja azt az alapfeltevést, hogy az érzelmi biztonság - mint a fejlődési folyamatok elsődleges feltétele - nem helyettesíthető tüneti kezelési stratégiákkal. A biztonságos bázis megvonásának vizsgálata rámutatott, hogy a kötődési kapcsolat minősége és stabilitása közvetlen hatással van a fejlődési vívmányok megőrzésére.

A jelen dokumentum módszertani korlátait figyelembe véve az eredmények elsősorban hipotézisalkotó és reflektív funkcióval bírnak, és kiindulópontul szolgálhatnak egy szigorúbb módszertani keretben, etikai engedéllyel végzett jövőbeli vizsgálathoz.

Záró szakmai ajánlás: a különleges bánásmódot igénylő gyermekek intézményi gondozásában az érzelmi biztonság megteremtése nem privilégium, hanem a fejlődés neurobiológiailag megalapozott és a szakirodalomban konszenzusos alapfeltétele.

Referenciák

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation.* Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 978-0-89859-461-4

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment.* Basic Books. ISBN: 978-0-465-00543-7

Bowlby, J. (1980). *Attachment and loss: Vol. 3. Loss: Sadness and depression.* Basic Books. ISBN - 978-0-465-04238-8; 0-465-04238-4; 0-465-04237-6

ENSZ (1989). *A gyermek jogairól szóló egyezmény.* Kihirdette: 1991. évi LXIV. törvény. Elérhetőség: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

Kübler-Ross, E. (1969). *On death and dying.* Macmillan. DOI: 10.13140/RG.2.2.27888.78080

Ódor, A. (2025). *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazása gyógypedagógiai környezetben: Módszertani beszámoló* Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18076570

Ódor, A. (2026). *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazása gyógypedagógiai környezetben - Módszertani beszámoló - A stabilitás és a viselkedési minták belsővé válásának folyamata: féléves terepi tapasztalatok egy gyógypedagógiai csoportban.* Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.19073012

Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2006). *The boy who was raised as a dog: And other stories from a child psychiatrist's notebook.* Basic Books. ISBN: 978-0-465-05652-1

Schore, A. N. (2003). *Affect dysregulation and disorders of the self.* W. W. Norton & Company. https://psycnet.apa.org/record/2003-00021-000

van der Kolk, B. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma.* Viking. ISBN: 978-0-670-78593-3

Walker, P. (2013). *Complex PTSD: From surviving to thriving.* Azure Coyote Publishing. ISBN: 1492871842

Zeanah, C. H., & Gleason, M. M. (2014). Annual research review: Attachment disorders in early childhood - clinical presentation, causes, correlates, and treatment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry,* 56(3), 207–222. DOI: 10.1111/jcpp.12347

Érdekkonfliktus-nyilatkozat

A szerző nyilatkozik, hogy a jelen közlemény megírásával kapcsolatban érdekkonfliktus nem áll fenn. Az ESV-modell a szerző saját szakmai fejlesztése; a jelen dokumentum nem kereskedelmi, hanem kizárólag szakmai-reflektív célokat szolgál.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönetét fejezi ki mindazon szülőknek és szakmai partnereknek, akik a terepi munka során együttműködő partnerei voltak, valamint az érintett gyermekeknek, akik bizalmukkal lehetővé tették e tapasztalatok rögzítését.